



Douleur thoracique

Par [Andrea D. Thompson](#), MD, PhD, University of Michigan;

[Michael J. Shea](#), MD, Michigan Medicine at the University of Michigan

Reviewed By [Jonathan G. Howlett](#), MD, Cumming School of Medicine, University of Calgary

Vérifié/Révisé août 2024

La douleur thoracique est un symptôme de présentation très fréquent. Beaucoup de patients sont conscients qu'il s'agit d'un avertissement de troubles engageant le pronostic vital et demandent un bilan pour des symptômes minimes. D'autres patients, dont beaucoup ont une maladie grave, minimisent ou ignorent ces avertissements. La perception de la douleur (son caractère et sa gravité) varie grandement d'un individu à l'autre, ainsi qu'entre les hommes et les femmes. Cependant, une douleur thoracique ne doit jamais être négligée avec légèreté sans avoir expliqué sa cause.

Physiopathologie de la douleur thoracique

Le cœur, les poumons, l'œsophage et les gros vaisseaux adressent des afférences viscérales par les mêmes ganglions thoraciques végétatifs. Un stimulus douloureux dans ces organes est généralement perçu comme d'origine thoracique, mais comme les fibres nerveuses afférentes se chevauchent dans les ganglions dorsaux, une douleur thoracique peut être ressentie n'importe où entre le nombril et l'oreille, y compris les membres supérieurs.

Les stimuli douloureux provenant d'organes thoraciques peuvent provoquer un inconfort décrit comme une pression, une déchirure, des gaz avec besoin d'éructer, une indigestion, une brûlure ou une douleur sourde. Rarement, d'autres descriptions de douleur thoracique sont fournies, comme une douleur ressemblant à des coups de poignard ou à une aiguille. Lorsque la sensation est d'origine viscérale, de nombreux patients nient leur douleur et insistent pour la considérer comme un simple "malaise."

Étiologie de la douleur thoracique

Beaucoup de pathologies entraînent une douleur ou une gêne thoracique. Ces troubles peuvent impliquer les systèmes cardiovasculaire, gastro-intestinal, pulmonaire, neurologique ou musculo-squelettique (voir tableau [Certaines causes de douleur thoracique](#)).

Certains troubles engagent **immédiatement le pronostic vital**:

- [Syndromes coronariens aigus](#) (infarctus du myocarde aigu/angor instable)
- Dissection de [l'aorte thoracique](#)

- [Pneumothorax compressif](#)
- [Rupture œsophagienne](#)
- [Embolie pulmonaire](#)

D'autres causes vont de causes graves, mettant potentiellement en jeu la vie à des causes qui sont simplement désagréables.

Globalement, les **causes les plus fréquentes** sont les suivantes

- Des troubles de la paroi thoracique (c'est-à-dire, impliquant les muscles, les côtes ou les cartilages)
- Des maladies pleurales
- Des troubles gastro-intestinaux (p. ex., [maladie du reflux gastro-œsophagien](#) ou [spasme œsophagien](#), [maladie ulcéreuse](#), [cholélithiase](#))
- Des [syndromes coronariens aigus](#) et un [angor](#) stable

Dans certains cas, aucune cause ne peut être confirmée même après un bilan complet.

TABLEAU

Certaines causes de douleur thoracique

Cause*	Signes évocateurs	Procédure diagnostique†
Cardiovasculaire		
1 Ischémie myocardique (infarctus du myocarde aigu / angor instable / angor)	Douleur aiguë, constrictive, irradiant vers la mâchoire ou le bras Douleur à l'effort soulagée par le repos (angor) Gallop B4 Parfois souffle systolique de régurgitation (insuffisance) mitrale Souvent signes d'alarme‡	ECG et biomarqueurs cardiaques en série Parfois, échocardiogramme (traditionnel, et/ou échographie au lit du malade) Imagerie de stress ou angio-TDM envisagée chez les patients qui ont des signes ECG négatifs ou inchangés et aucune élévation du biomarqueur cardiaque lors des tests en série Souvent cathétérisme cardiaque et

Cause*	Signes évocateurs	Procédure diagnostique†
1 Dissection de l'aorte thoracique	Douleur soudaine à type de déchirure irradiant dans le dos Certains patients font une syncope, un accident vasculaire cérébral ou ont une ischémie de la jambe Les pouls ou la pression artérielle peuvent être différents au niveau des membres Âge > 55 ans HTA Signes d'alarme‡	coronarographie si les signes sont positifs D-dimère chez les patients à faible risque Radiographie thoracique, qui peut révéler un élargissement du médiastin Chez les patients qui sont hémodynamiquement stables: angio-TDM, éventuellement angio-IRM ou échocardiographie transœsophagienne Chez les patients qui sont hémodynamiquement instables: échocardiographie transœsophagienne au lit du malade
2 Myocardite	Fièvre, dyspnée, asthénie, douleur thoracique (en cas de myopéricardite), infection récente, virale ou autre Parfois, signes d'insuffisance cardiaque et/ou de péricardite	ECG Biomarqueurs cardiaques sériques VS Protéine C réactive Habituellement, échocardiographie ou IRM cardiaque
2 Péricardite	Douleur intense constante ou intermittente souvent aggravée par la respiration, la déglutition de la nourriture ou le décubitus dorsal et soulagée par la position	ECG Biomarqueurs cardiaques sériques (montrant parfois une élévation des taux de troponine et de CK-MB minimes si une

Cause*	Signes évocateurs	Procédure diagnostique†
	assise ou penchée en avant Frottement péricardique Distension de la jugulaire (en cas de péricardite constrictive ou d'épanchement péricardique important ou à accumulation rapide)	myocardite associée est présente) Échocardiogramme transthoracique pour rechercher un épanchement péricardique
Gastro-intestinal		
1 Rupture œsophagienne	Douleur soudaine, sévère après des vomissements ou une instrumentation (p. ex., œsophagogastroscope ou échocardiographie transœsophagienne) Crépitements sous-cutané détecté à l'auscultation Signes d'alarme‡	Radiographie thoracique Œsophagographie avec contraste hydrosoluble pour confirmation
2 Pancréatite	Douleur épigastrique ou de la partie basse du thorax qui est souvent plus intense couché à plat et soulagée en position penchée en avant Vomissements Douleur abdominale haute Le choc Fièvre Souvent antécédents d'abus d'alcool ou de maladie des voies biliaires	Lipase sérique (> 3 fois la limite supérieure de la normale) TDM abdominale
3 Maladie des voies biliaires	Douleur récurrente au niveau épigastrique ou de	Échographie de la vésicule biliaire

Cause*	Signes évocateurs	Procédure diagnostique†
	l'hypochondre droit apparaissant après les repas (mais pas à l'effort)	Parfois cholescintigraphie (acide iminodiacétique hépatique [HIDA])
3 Troubles de la motilité œsophagienne	Douleur de longue date, d'apparition insidieuse, pouvant ou non accompagner la déglutition Habituellement aussi difficulté à la déglutition	TOGD Manométrie œsophagienne
3 Reflux gastro-œsophagien maladie	Douleurs récidivantes irradiant de l'épigastre à la gorge qui est exacerbée par la position penchée en avant ou couchée et soulagée par les antiacides	Bilan clinique Parfois, endoscopie Parfois, examens de la motricité
3 Ulcère gastroduodéal	Douleur épigastrique récurrente et vague, en particulier chez un patient qui fume ou consomme de l'alcool en quantité excessive, atténuée par les aliments et/ou les antiacides. Aucun signe d'alarme (sauf perforation ou saignement) ‡	Bilan clinique Parfois, endoscopie Parfois, tests pour <i>Helicobacter pylori</i>
Pulmonaire		
1 Embolie pulmonaire	Souvent douleur pleurale, dyspnée, tachycardie Parfois, légère fièvre, hémoptysie, choc Plus probable en présence de facteurs de risque	Risk stratification (Wells Criteria, Pulmonary Embolism Rule-out Criteria [PERC rule], Revised Geneva Scoring System) ECG, radiographie thoracique, BNP, troponine (évaluer un autre diagnostic et fournir

Cause*	Signes évocateurs	Procédure diagnostique†
		des informations pronostiques) Parfois, échographie au lit du malade (taille et fonction du ventricule droit, septum interventriculaire, veine cave inférieure) Parfois dosage des D-dimères Parfois, angiographie pulmonaire par TDM
1 Pneumothorax compressif	Dyspnée importante, hypotension, distension veineuse cervicale, diminution unilatérale du murmure vésiculaire et hypersonorité à la percussion Parfois, présence d'air sous-cutané	Habituellement bilan clinique Évident sur la radiographie thoracique Parfois, échographie immédiate au lit du malade
2 Pneumonie	Fièvre, frissons, toux et parfois expectorations purulentes Souvent dyspnée, tachycardie, signes de condensation	Radiographie thoracique
2 Pneumothorax	Parfois, douleur pleurale thoracique, diminution unilatérale des bruits respiratoires et/ou air sous-cutané	Radiographie thoracique Parfois, échographie au lit du malade ou TDM du thorax
3 Pleurésie	Antécédents de pneumonie, d'embolie pulmonaire ou d'infection virale respiratoire	Habituellement bilan clinique Parfois, radiographie de thorax

Cause*	Signes évocateurs	Procédure diagnostique†
	Douleur à la respiration, toux Parfois un frottement pleural mais examen sans autre particularité	
Autres		
2 Divers cancers thoraciques	Douleur variable mais parfois pleurétique Parfois, toux chronique, antécédents de tabagisme, signes de maladie chronique (perte de poids, fièvre), adénopathies cervicales	Radiographie thoracique TDM du thorax si les radiographies sont compatibles avec un cancer Scintigraphie osseuse envisagée en cas de douleurs costales, persistantes, focales
3 Douleur musculosquelettique de la paroi thoracique (p. ex., traumatisme, sur-utilisation, ou costochondrite)	Souvent suggérée par l'anamnèse Douleurs typiquement persistantes (durant plusieurs jours ou plus), aggravées par les mouvements actifs et passifs Douleur diffuse ou focale	Bilan clinique
3 Fibromyalgie	Douleur presque constante, affectant plusieurs régions du corps ainsi que le thorax Typiquement, fatigue et troubles du sommeil Points de déclenchement multiples	Bilan clinique
3 Infection par le zona (herpes zoster)	Douleur intense, en bande thoracique unilatérale	Bilan clinique

Cause*	Signes évocateurs	Procédure diagnostique†
	Eruption dermatomique classique, unilatérale, vésiculaire Douleur pouvant précéder l'exanthème de plusieurs jours	
3 Idiopathique	Divers signes Aucun signe d'alarme‡	Diagnostic d'exclusion

*La gravité des causes varie comme indiqué:

¹Mise en jeu immédiate du pronostic vital.

²Risques vitaux potentiels.

³Inconfortable, mais habituellement non dangereux.

†La plupart des patients qui présentent une douleur thoracique doivent subir une oxymétrie de pouls, un ECG et une radiographie de thorax (examens de base). En cas de suspicion d'ischémie coronarienne, les biomarqueurs cardiaques sériques (troponine, CK-MB) doivent également être vérifiés.

‡Les signes d'alarme comprennent des signes vitaux anormaux (tachycardie, bradycardie, tachypnée, hypotension), des signes d'hypoperfusion (p. ex., confusion, teint gris, transpiration), une dyspnée, un murmure vésiculaire ou des pouls asymétriques, de nouveaux souffles ou un pouls paradoxal > 10 mmHg.

BNP = brain (B-type) natriuretic peptide; CK-MB = creatine kinase, MB fraction; ESR = erythrocyte sedimentation rate; POCUS = point-of-care ultrasound (échographie au lit du malade); S4 = fourth heart sound; TEE = transesophageal echocardiogram.

Évaluation d'une douleur thoracique

Anamnèse

L'**anamnèse de la maladie actuelle** doit rechercher la localisation, la durée, le caractère et la qualité de la douleur. Il faut interroger le patient sur tout événement déclenchant (p. ex., surmenage des

muscles thoraciques), ainsi que tout facteur déclenchant et calmant. Les facteurs spécifiques à rechercher comprennent le fait que la douleur soit présente à l'effort ou au repos, l'existence d'un stress psychologique, le fait que la douleur se produise lors de la respiration ou de la toux, qu'elle s'accompagne de difficultés à avaler, qu'elle soit en relation avec les repas, qu'elle soit soulagée ou aggravée par certaines positions (p. ex., couché à plat, penché en avant). Des antécédents d'épisodes semblables et leurs circonstances de survenue doivent être notés avec une attention particulière accordée à la similitude ou à l'absence de similitude avec les épisodes actuels et au fait que la fréquence et/ou la durée des épisodes augmentent. D'importants symptômes associés à rechercher comprennent une [dyspnée](#), des [palpitations](#), des [syncopes](#), une transpiration, des nausées ou des vomissements, une toux, une fièvre ou des frissons.

La **revue des systèmes** doit rechercher des symptômes de causes possibles, dont des douleurs de jambe et/ou une tuméfaction ([thrombose veineuse profonde](#) et donc une possible [embolie pulmonaire](#)) et une faiblesse chronique, une sensation de malaise et une perte de poids (cancer).

La **recherche des antécédents médicaux** doit porter sur les causes connues, en particulier les troubles cardiovasculaires et gastro-intestinales et toute investigation ou examen cardiaque (p. ex., test d'effort, sondage). Les [facteurs de risque de coronaropathie](#) (p. ex., HTA, hyperlipidémie, diabète, maladie cérébrovasculaire, tabagisme) ou d'[embolie pulmonaire](#) (p. ex., blessure du membre inférieur, intervention chirurgicale récente, immobilisation, cancer connu, grossesse) seront également notés.

L'anamnèse médicamenteuse doit prendre en compte la prise de médicaments et de drogues qui peuvent déclencher des spasmes des artères coronaires (p. ex., cocaïne, triptans) ou des maladies gastro-intestinales (en particulier l'alcool, les AINS).

L'anamnèse familiale doit rechercher des antécédents d'[infarctus du myocarde](#) (particulièrement chez les apparentés au 1^{er} degré à un âge précoce, c'est-à-dire < 55 ans chez l'homme et < 60 ans chez la femme) et de dyslipidémie.

Examen clinique

L'étendue de l'examen clinique est guidée par la suspicion clinique. Les fonctions vitales et le poids sont mesurés et l'index de masse corporelle (IMC) peut être calculé. Les pouls sont palpés aux deux bras et aux deux jambes, la pression artérielle est mesurée aux deux bras.

L'aspect général est noté (p. ex., pâleur, transpiration, cyanose, anxiété).

Le cou est inspecté à la recherche d'une distension veineuse et d'un reflux hépatojugulaire. Le cou est palpé à la recherche des pouls carotidiens, d'adénopathies ou d'une anomalie de la thyroïde. Les artères carotides sont auscultées à la recherche d'un souffle.

Les poumons sont percutés et auscultés pour évaluer la présence et la symétrie du [murmure vésiculaire](#), de signes de congestion (râles secs ou humides), de condensation (pectoriloquie), de frottements et d'épanchements pleuraux (diminution du murmure vésiculaire, matité à la percussion).

L'examen cardiaque note l'intensité et le temps du 1^{er} bruit cardiaque (B1) et du 2^e bruit cardiaque (B2), le mouvement respiratoire de la composante pulmonaire du B2, les frottements péricardiques,

d'éventuels souffles et galops. Lorsque des souffles sont détectés, leur évolution dans le temps, leur durée, leur timbre, leur forme et leur intensité ainsi que la réponse aux modifications de position, au serrage des poings et à la manœuvre de Valsalva doivent être notées. Lorsque des galops sont détectés, il convient de différencier entre le 4e bruit cardiaque (S4), qui est souvent présent en cas de dysfonctionnement diastolique ou d'ischémie myocardique et un 3e bruit cardiaque (S3), qui est présent en cas de dysfonctionnement systolique.

Le thorax est examiné à la recherche de lésions cutanées traumatiques ou d'un zona (herpes zoster) et palpé à la recherche de crépitations (suggère la présence d'air sous-cutané) et douleur. L'abdomen est palpé à la recherche d'une sensibilité, d'une organomégalie et d'autres masses ou sensibilités, en particulier au niveau des régions épigastriques et de l'hypochondre droit.

Les membres inférieurs sont examinés et les pouls artériels palpés, la perfusion, la présence d'œdèmes, de varicosités veineuses et de signes de thrombose veineuse profonde est notée (p. ex., tuméfaction, érythème, sensibilité).

Le [pouls paradoxal](#) peut être mesuré s'il existe un risque clinique de tamponnade péricardique (bruits cardiaques distants, distension veineuse jugulaire, une dyspnée, une tachycardie ou une hypotension inexpliquées).

Signes d'alarme

Certains signes évoquent des étiologies graves de douleurs thoraciques:

- Signes vitaux anormaux (tachycardie, bradycardie, tachypnée, hypotension)
- Signes d'hypoperfusion (p. ex., confusion, teint livide, transpiration)
- Essoufflement
- Hypoxémie à l'oxymétrie de pouls
- Asymétrie du murmure vésiculaire ou des pouls
- Souffles cardiaques nouveaux
- Pouls paradoxal > 10 mmHg

Interprétation des signes

La symptomatologie des troubles thoraciques est très variable, et celle de maladies graves et non graves se chevauche souvent. Bien que la présence de signes d'alarme indique une probabilité élevée de maladie grave et que plusieurs troubles aient des manifestations "classiques" (voir tableau [Certaines causes de douleur thoracique](#)) nombre de patients qui ont une maladie grave ne présentent pas initialement cette symptomatologie classique. Par exemple, les patients qui présentent une ischémie myocardique peuvent ne se plaindre que d'une indigestion ou avoir une paroi thoracique très sensible à la palpation. Une grande prudence est importante dans l'évaluation des patients qui présentent une douleur thoracique. Cependant, certaines distinctions et généralisations sont possibles.

La **durée de la douleur** peut fournir des indices sur la gravité de la maladie. Les douleurs de longue date (c'est-à-dire, pendant des semaines ou des mois) ne sont pas une manifestation d'un trouble mettant immédiatement le pronostic vital en jeu. Cette douleur est souvent d'origine

musculosquelettique, bien qu'une origine gastro-intestinale ou un cancer doive être envisagée, en particulier chez les patients âgés. De même, des douleurs brèves (< 5 s), tranchantes, intermittentes proviennent rarement de troubles graves. Les troubles graves se manifestent généralement par une douleur qui dure quelques minutes ou heures, même si les épisodes peuvent être récurrents (p. ex., un [angor instable](#) peut provoquer plusieurs épisodes de douleur sur 1 ou plusieurs jours).

L'**âge du patient** est utile dans l'évaluation de la douleur thoracique. Une douleur thoracique chez un enfant ou un jeune adulte (de < 30 ans) est moins susceptible d'être liée à une ischémie myocardique, bien que des infarctus du myocarde puissent survenir chez des sujets d'une vingtaine d'années. Les troubles musculosquelettiques et pulmonaires sont des causes plus fréquentes chez l'enfant et le jeune adulte.

L'**aggravation et le soulagement** des symptômes sont également utiles dans l'évaluation de la douleur thoracique. Bien que l'angor puisse être ressenti partout entre l'oreille et l'ombilic, il est généralement lié à un stress physique ou émotionnel de manière constante, c'est-à-dire que les patients ne ressentent pas de l'angor en montant un étage un jour et tolèrent trois étages le lendemain. L'angor nocturne est caractéristique de [syndromes coronaires aigus](#), d'une [insuffisance cardiaque](#) ou d'un spasme d'une artère coronaire.

La douleur de nombreuses maladies, graves et mineures, peut être exacerbée par la respiration, les mouvements ou la palpation du thorax. Ces signes ne sont pas spécifiques d'une origine qui se situe dans la paroi thoracique.

La nitroglycérine peut soulager la douleur de l'ischémie myocardique et des spasmes des muscles lisses non cardiaques (p. ex., troubles œsophagiens ou biliaires); son efficacité ou son absence d'efficacité ne doit donc pas être utilisée pour le diagnostic.

Les **signes associés** peuvent également faire évoquer une cause. La fièvre n'est pas spécifique mais, si elle est accompagnée de toux, elle évoque une cause pulmonaire. Les patients qui présentent un [syndrome de Raynaud](#) ou des [migraines](#) ont parfois des spasmes coronariens.

L'existence ou non de facteurs de [risque de coronaropathie](#) (p. ex., [HTA](#), [hypercholestérolémie](#), tabagisme, [obésité](#), [diabète](#), antécédents familiaux positifs) modifie la probabilité d'une coronaropathie sous-jacente, mais ne permet pas le diagnostic de la cause d'une douleur thoracique donnée. Les patients qui présentent ces facteurs peuvent très bien avoir une autre cause de douleur thoracique et les patients qui ne les ont pas peuvent avoir un [syndrome coronarien aigu](#). Cependant, une coronaropathie connue chez un patient qui a une douleur thoracique augmente la probabilité que ce diagnostic soit en cause (en particulier si le patient décrit les symptômes par des termes tels que "comme mon angine de poitrine" ou "comme la dernière crise cardiaque"). Une anamnèse de [maladie vasculaire périphérique](#) évoque également la possibilité que l'[angor](#) soit la cause des douleurs thoraciques.

Examens complémentaires

Les tests peuvent comprendre un ECG, des biomarqueurs cardiaques et des examens d'imagerie (1). Chez l'adulte, en cas de douleur thoracique aiguë, un risque vital immédiat doit être exclu. La plupart

des patients doivent initialement subir une oxymétrie de pouls, un [ECG](#) et une radiographie thoracique. Parfois, en particulier en cas d'instabilité hémodynamique, une échographie au lit du malade ou un échocardiogramme complet peut également être utile pour mieux évaluer les causes potentiellement mortelles (2). L'échocardiographie peut être particulièrement utile pour identifier un dysfonctionnement ventriculaire gauche ou droit, mettre en évidence une surcharge de pression du ventricule droit, une pathologie valvulaire, des épanchements péricardiques et des signes de tamponnade péricardique.

Si les symptômes suggèrent un [syndrome coronarien aigu](#) ou si aucune autre cause n'est évidente (en particulier chez les patients à risque), les [taux de troponine](#) sont mesurés. Une évaluation rapide est essentielle parce qu'en cas d'infarctus du myocarde ou d'un autre syndrome coronarien aigu, on doit envisager un cathétérisme cardiaque urgent (si disponible). Un cathétérisme immédiat est indiqué chez les patients présentant une élévation du segment ST à l'ECG ou en cas d'infarctus du myocarde sans sus-décalage du segment ST (NSTEMI) plus des caractéristiques à haut risque (p. ex., hypotension, troubles du rythme ventriculaires, douleur thoracique persistante malgré une prise en charge médicale optimale), ou score de risque élevé (score de risque GRACE [3]). Chez ces patients, un cathétérisme dans les 90 minutes suivant l'arrivée est considéré comme un traitement standard. Chez les patients à faible risque et en cas de NSTEMI possible, un cathétérisme non urgent associé à une prise en charge médicale rapide et non invasive peut être poursuivi.

Certains résultats d'examens anormaux confirment le diagnostic (p. ex., [infarctus du myocarde](#), [pneumothorax](#), [pneumonie](#)). D'autres anomalies suggèrent un diagnostic ou au moins la nécessité de poursuivre les investigations (p. ex., un contour aortique anormal sur la radiographie de thorax impose de rechercher une [dissection de l'aorte thoracique](#)). Ainsi, si les résultats des examens initiaux sont normaux, la dissection aortique thoracique, le pneumothorax compressif et la rupture œsophagienne sont très peu probables. Cependant, dans les syndromes coronariens aigus, l'ECG peut ne pas changer pendant plusieurs heures ou parfois ne pas changer du tout, et en cas d'embolie pulmonaire, l'oxygénation peut être normale. Ainsi, d'autres examens devront être basés sur l'anamnèse et l'examen clinique (voir tableau [Certaines causes de douleur thoracique](#)). De plus, les anomalies du segment ST sur l'ECG peuvent être aspécifiques ou liées à des troubles anciens, la comparaison avec les ECG précédents est donc importante.

Puisqu'un seul ensemble normal de biomarqueurs cardiaques n'exclut pas une cause cardiaque, les patients dont les symptômes suggèrent un [syndrome coronarien aigu](#) doivent subir des mesures sériées du biomarqueur cardiaque troponine et des ECG en série. Le [traitement médicamenteux d'un syndrome coronaire aigu suspecté](#) est débuté en attendant les résultats du 2e dosage du taux de la troponine, sauf contre-indication évidente. Un essai d'administration de nitroglycérine sublinguale ou d'un liquide antiacide oral ne permet pas de différencier de manière fiable une ischémie myocardique d'un reflux gastro-œsophagien ou d'une gastrite. Ces deux affections peuvent être calmées par ces mêmes médicaments.

La troponine sera élevée dans les syndromes coronariens aigus sauf dans l'angor instable mais aussi souvent dans d'autres troubles qui lèsent le myocarde (p. ex., [myocardite](#), [péricardite](#), [dissection aortique](#) impliquant le flux coronarien, [embolie pulmonaire](#), [insuffisance cardiaque](#), [sepsis sévère](#)). La CK (créatine kinase) peut être élevée par toutes les lésions des tissus musculaires, mais l'isoenzyme CK-MB est spécifique des lésions du myocarde. Cependant, la troponine est le marqueur cardiaque

standard d'une lésion du muscle cardiaque. Les progrès des dosages de la troponine à haute sensibilité permettent une évaluation en série plus rapide d'un possible syndrome coronarien aigu. Avec une valeur prédictive négative améliorée, la troponine à haute sensibilité peut également réduire la nécessité de tests supplémentaires chez les patients qui ont des biomarqueurs négatifs et a démontré qu'elle permettait aux patients de sortir plus rapidement de l'hôpital (4). Des lignes directrices recommandent d'utiliser les taux de troponine normaux et une TDM coronarienne négative comme stratégie fiable d'exclusion d'un syndrome coronarien aigu en cas de douleur thoracique et sans signes d'alarme (5). Le suivi des tests initiaux négatifs (de façon aiguë ou sur quelques jours) par un ECG d'effort ou une imagerie d'effort est également raisonnable, en particulier en cas de suspicion clinique d'intermédiaire à élevée de maladie coronarienne ou de risque élevé d'événements cardiovasculaires indésirables majeurs (score HEART [6]).

Si la possibilité d'une embolie pulmonaire est évoquée, un dosage du D-dimère est effectué chez les patients à risque faible et intermédiaire. La probabilité d'embolie pulmonaire est modifiée par un grand nombre de facteurs cliniques, qui peuvent être utilisés pour définir une proposition d'examens. Nombre de ces facteurs sont inclus dans les systèmes de notation qui aident à déterminer la probabilité d'embolie pulmonaire tels que le Wells Scoring System, le Revised Geneva Scoring System, et le Pulmonary Embolism Rule Out Criteria (PERC, 7,8,9).

Chez les patients souffrant de douleurs thoraciques chroniques, une menace immédiate pour la vie est peu probable. La plupart des médecins pratiquent initialement une radiographie de thorax et d'autres examens en se basant sur la symptomatologie.

CALCULATEUR CLINIQUE

[Score de Wells prédictif de l'embolie pulmonaire](#)



Références pour l'évaluation

1. [Writing Committee, Kontos MC, de Lemos JA, et al](#): 2022 ACC Expert Consensus Decision Pathway on the Evaluation and Disposition of Acute Chest Pain in the Emergency Department: A Report of the American College of Cardiology Solution Set Oversight Committee. *J Am Coll Cardiol* 80(20):1925–1960, 2022. doi:10.1016/j.jacc.2022.08.750
2. [Melgarejo S, Schaub A, Noble VE](#): Point of Care Ultrasound: An Overview. *American College of Cardiology: Latest in Cardiology*. October 31, 2017.
3. [Fox KA, Fitzgerald G, Puymirat E, et al](#): Should patients with acute coronary disease be stratified for management according to their risk? Derivation, external validation and outcomes using the updated GRACE risk score. *BMJ Open* 4(2):e004425, 2014. doi:10.1136/bmjopen-2013-004425
4. [Neumann JT, Sorensen NA, Schwemer T, et al](#): Diagnosis of myocardial infarction using a high sensitivity troponin I 1-hour algorithm. *JAMA Cardiol* 1(4):397–404, 2016. doi: 10.1001/jamacardio.2016.0695
5. [Gulati M, Levy PD, Mukherjee D, et al](#): 2021 AHA/ACC/ASE/CHEST/SAEM/SCCT/SCMR Guideline for the Evaluation and Diagnosis of Chest Pain: A Report of the American College of

Cardiology/American Heart Association Joint Committee on Clinical Practice Guidelines. *Circulation* 144(22):e368–e454, 2021. doi: 10.1161/CIR.0000000000001029

6. [Fernando SM, Tran A, Cheng W, et al](#): Prognostic Accuracy of the HEART Score for Prediction of Major Adverse Cardiac Events in Patients Presenting With Chest Pain: A Systematic Review and Meta-analysis. *Acad Emerg Med* 26(2):140–151, 2019. doi:10.1111/acem.13649

7. [Wells PS, Anderson DR, Rodger M, et al](#): Excluding pulmonary embolism at the bedside without diagnostic imaging: management of patients with suspected pulmonary embolism presenting to the emergency department by using a simple clinical model and d-dimer. *Ann Intern Med* 135(2):98–107, 2001. doi: 10.7326/0003-4819-135-2-200107170-00010

8. [Le Gal G, Righini M, Roy PM, et al](#): Prediction of pulmonary embolism in the emergency department: the revised Geneva score. *Ann Intern Med* 144(3):165–171, 2006. doi: 10.7326/0003-4819-144-3-200602070-00004

9. [Kline JA, Mitchell AM, Kabrhe C, et al](#): Clinical criteria to prevent unnecessary diagnostic testing in emergency department patients with suspected pulmonary embolism. *J Thromb Haemost* 2(8):1247–1255, 2004. doi: 10.1111/j.1538-7836.2004.00790.x

Traitement de la douleur thoracique

Une fois identifiées, les pathologies seront traitées. Généralement, lorsque l'étiologie n'apparaît pas clairement comme bénigne, le patient est hospitalisé ou admis dans une unité de surveillance pour un suivi cardiaque et un bilan plus approfondi. La [douleur](#) est traitée par le paracétamol ou des opioïdes selon les besoins, en attendant le diagnostic. Le soulagement de la douleur après un traitement par les opioïdes ne doit pas diminuer l'urgence d'écarter une maladie grave et potentiellement mortelle.

Si l'embolie pulmonaire est très probable, des médicaments anticoagulants doivent être administrés tout en continuant la procédure diagnostique; une autre embolie chez un patient qui ne reçoit pas d'anticoagulants peut être fatale.

Bases de gériatrie: douleur thoracique

La probabilité de maladie grave et potentiellement mortelle augmente avec l'âge. De nombreux patients âgés se remettent plus lentement que les patients jeunes mais, survivent pendant un temps significatif s'ils sont correctement diagnostiqués et traités. Les doses de médicaments sont généralement plus faibles, et la rapidité de l'augmentation des doses est plus lente. Des troubles chroniques (p. ex., maladie rénale chronique) sont souvent présents et peuvent compliquer le diagnostic et le traitement.

Points clés

- L'existence de risques vitaux doit être éliminée en premier.
- Certains troubles sévères, en particulier l'ischémie coronarienne et l'embolie pulmonaire, souvent, n'ont pas une présentation classique.

- La plupart des patients doivent avoir une oxymétrie de pouls, un ECG, une mesure des marqueurs cardiaques et une radiographie thoracique.
- Le bilan doit être rapide afin que les patients qui présentent un infarctus du myocarde avec élévation de ST ou d'autres critères d'indication d'une intervention puissent être au laboratoire de cathétérisme cardiaque (ou avoir une thrombolyse) dans les 90 minutes standards.
- Si l'embolie pulmonaire est très probable, des médicaments anticoagulants doivent être administrés tout en continuant la procédure diagnostique; une autre embolie chez un patient qui ne reçoit pas d'anticoagulants peut être fatale.



Copyright © 2026 Merck & Co., Inc., Rahway, NJ, États-Unis et ses sociétés affiliées. Tous droits réservés.